

Hemorragia posparto

1. Introducción y relevancia clínica

La **hemorragia posparto (HPP)** se define como la **pérdida de sangre ≥ 500 mL tras un parto vaginal o ≥ 1.000 mL tras cesárea**, o cualquier pérdida que produzca **inestabilidad hemodinámica**.

Se clasifica en:

- Primaria o inmediata:** ocurre dentro de las primeras **24 horas** del parto.
- Secundaria o tardía:** entre **24 horas y 6 semanas** posparto.

La HPP es una **emergencia obstétrica**. En Chile, según MINSAL (2023), es la **primera causa de morbilidad grave materna** en el puerperio inmediato, siendo la **atonía uterina** responsable de más del **70%** de los casos.

□ En el EUNACOM suelen preguntar:
“Puerpera con sangrado abundante e hipotensión 20 minutos después del parto, útero blando y aumentado → diagnóstico: hemorragia posparto por atonía uterina.”

2. Fisiopatología y bases conceptuales

Tras la expulsión de la placenta, los vasos del lecho placentario deben **contraerse eficazmente** para cerrar el flujo sanguíneo.

Si esta contracción no ocurre —por **atonía uterina**—, los vasos permanecen abiertos y se produce hemorragia.

Mecanismos principales (las “4 T”):

Causa	Mecanismo	Frecuencia aproximada
Tone (Tono)	Atonía uterina	70–80%

Tissue (Tejido)	Retención de restos placentarios o coágulos	10%
Trauma	Laceraciones del canal del parto, hematomas, inversión uterina	10%
Thrombin (Trombina)	Trastornos de coagulación	1–5%

3. Factores de riesgo

Maternos	Obstétricos / Parto	Iatrogénicos
Multiparidad, anemia, obesidad	Macrosomía, parto prolongado o precipitado	Sobredistensión uterina (polihidroamnios, gemelar)
Preeclampsia, placenta previa	Uso excesivo de oxitocina, corioamnionitis	Cesárea previa, instrumentación obstétrica
Medicamentos relajantes uterinos	Retención placentaria	Inducción prolongada

□ Sin embargo, la mayoría de las HPP ocurren **sin factores de riesgo identificables**, por lo que toda atención de parto debe estar preparada.

4. Diagnóstico clínico

A. Sospecha

- Sangrado vaginal visible abundante (>500 mL).
- Hipotensión, taquicardia, palidez, diaforesis.

- Útero blando, grande, por encima del ombligo.

B. Confirmación

- Evaluación clínica rápida y simultánea con maniobras terapéuticas.
- Control hemodinámico y cuantificación de pérdida sanguínea.

☐ La cuantificación visual subestima el sangrado: siempre sospechar HPP ante signos clínicos de shock.

5. Evaluación inicial y estabilización

1. **Llamar ayuda y activar protocolo de HPP.**
2. **Evaluar ABC:**
 - Vía aérea permeable.
 - Oxígeno al 100% (10–15 L/min).
 - Dos vías venosas gruesas (14–16 G).
3. **Monitoreo hemodinámico.**
4. **Extracción de muestras:** hemograma, coagulación, fibrinógeno, grupo y Rh.
5. **Reposición:** cristaloideos tibios (1–2 L) + sangre según necesidad.
6. **Mantener normotermia.**

☐ La prioridad inicial es **salvar a la paciente**, no diagnosticar la causa exacta.

6. Identificación de la causa: las “4 T”

Paso

Evaluación clínica

Tono	Palpar útero: blando = atonía
Tejido	Revisar placenta y membranas: restos retenidos
Trauma	Explorar canal del parto, periné, cérvix, vagina
Trombina	Revisar signos de coagulopatía, sangrado difuso, pruebas de coagulación

7. Manejo de la atonía uterina (HPP primaria más frecuente)

Paso 1. Maniobras iniciales

- **Masaje uterino bimanual** inmediato.
- **Oxitocina:** 10 UI EV lenta o en infusión continua (30 UI en 500 mL SF a 125 mL/h).
- **Asegurar vaciamiento vesical.**
- Si no responde → paso siguiente.

Paso 2. Uterotónicos de segunda línea

1. **Metilergometrina 0,2 mg IM** (no usar en hipertensas o preeclámpticas).
2. **Carboprost (15-metil PGF₂α)** 250 µg IM cada 15–20 min (máx. 2 mg).
 - Contraindicado en asma o enfermedad pulmonar.
3. **Misoprostol 800–1.000 µg rectal o sublingual.**

□ En hospitales chilenos, el esquema usual es: oxitocina → metilergometrina → misoprostol.

Paso 3. Medidas mecánicas o quirúrgicas

- Taponamiento uterino con balón Bakri o sonda Foley múltiple.
 - Suturas compresivas tipo B-Lynch.
 - Ligas vasculares (arterias uterinas o hipogástricas).
 - Histerectomía obstétrica si sangrado incontrolable.
-

8. Causas menos frecuentes

A. Retención de restos placentarios

- Diagnóstico: placenta incompleta, sangrado persistente con útero firme.
- Confirmación: ecografía transvaginal.
- Tratamiento: extracción manual o legrado bajo cobertura antibiótica.

B. Trauma del canal del parto

- Sospecha: sangrado con útero firme.
- Manejo: reparación quirúrgica inmediata (desgarros vaginales, cervicales o episiotomía dehiscentes).

C. Trastornos de coagulación

- Causas: preeclampsia severa, abrupcio placentae, sepsis.
 - Manejo: transfundir plasma fresco, plaquetas, crioprecipitado según déficit.
-

9. Hemorragia posparto secundaria (tardía)

Definición:

Sangrado entre las 24 horas y las 6 semanas posparto.

Causas principales:

- Restos placentarios retenidos.
- Subinvolución del lecho placentario.
- Endometritis o infección.
- Trastornos de coagulación tardíos.

Diagnóstico:

- Sangrado persistente o intermitente tras puerperio.
- Ecografía: restos o contenido intrauterino.

Tratamiento:

- Antibióticos + uterotónicos.
- Legrado o aspiración uterina si restos retenidos.
- Transfusión si anemia o sangrado significativo.

10. Profilaxis de la hemorragia posparto

Según MINSAL y OMS:

1. **Administrar oxitocina 10 UI IM o EV tras la salida del hombro anterior** (manejo activo del alumbramiento).
2. **Tracción controlada del cordón.**
3. **Masaje uterino tras la expulsión de la placenta.**
4. **Revisar integridad placentaria y canal del parto.**

☐ Estas medidas reducen la incidencia de HPP en más de un 60%.

11. Reposición y soporte transfusional

Componente	Indicaciones
Concentrado de glóbulos rojos	Hb <7 g/dL o inestabilidad hemodinámica
Plasma fresco congelado	INR >1,5 o sangrado difuso
Plaquetas	<75.000/ μ L y sangrado activo
Crioprecipitado	Fibrinógeno <200 mg/dL
Meta: Hb $\geq$ 8 g/dL y fibrinógeno >200 mg/dL.	

12. Pronóstico

- Mortalidad materna <1% con manejo precoz y adecuado.
 - Riesgo de anemia crónica y lactancia dificultosa si no se corrige.
 - Requiere seguimiento cercano en puerperio temprano.
-

13. Perlas clínicas y errores comunes en EUNACOM



Perlas

1. HPP = pérdida >500 mL tras parto vaginal o >1.000 mL tras cesárea.
2. **Causa más frecuente:** atonía uterina.
3. **Primera medida:** masaje uterino + oxitocina.
4. **Metilergometrina:** evitar en hipertensas/preeclámpticas.

5. **Misoprostol:** útil si no hay respuesta o recursos limitados.
6. **Útero firme con sangrado persistente** → **trauma o restos.**
7. **Profilaxis:** oxitocina tras alumbramiento.



Errores comunes

- No iniciar oxitocina de inmediato.
- No cuantificar pérdidas.
- No revisar canal del parto.
- Aplicar metilergometrina en preeclampsia.
- Subestimar hemorragia “moderada” sin monitorización.

14. Resumen final (5–7 ideas clave)

1. **HPP:** pérdida sanguínea ≥ 500 mL (vaginal) o ≥ 1.000 mL (cesárea).
2. **Causa principal:** atonía uterina (70–80%).
3. **Manejo inicial:** masaje uterino, oxígeno, líquidos, oxitocina EV.
4. **Uterotónicos escalonados:** oxitocina → metilergometrina → misoprostol → cirugía.
5. **Profilaxis universal:** manejo activo del alumbramiento con oxitocina 10 UI.
6. **Útero firme con sangrado** → **sospechar trauma o restos retenidos.**
7. **No usar metilergometrina en preeclampsia.**